

免费获得国外相关药品，最快 1 个工作日回馈药物信息

出境医 / 临床实验 / 体细胞疾病患者失眠（CBTI）的认知行为疗法（CBTI）

体细胞疾病患者失眠（CBTI）的认知行为疗法（CBTI）

[研究细节](#) | [表视图](#) | [研究细节](#) | [表视图](#)

研究描述

简要摘要：
失眠症常见于合并症，例如风湿病，癌症，心脏和肺部疾病或胃肠道疾病。疼痛，呼吸困难和疾病的其他症状会使睡眠问题恶化并引起失眠。反过来，失眠可能会加剧疼痛，疲劳并降低体细胞疾病患者的生活质量。该项目旨在评估Diakonhjemmet医院为失眠和体细胞疾病患者提供的课程。该课程基于认知行为疗法，这是一种记录的失眠治疗方法。

病情或疾病	干预/治疗	阶段
失眠失眠症 慢性 睡眠开始和维持障碍 睡眠障碍 睡眠障碍 慢性疾病 失眠，由于疾病 失眠，心理生理学	行为：失眠的认知行为疗法（CBTI）	不适用

学习规划

研究类型：	介入（临床试验）
估计入学人数：	40名参与者
分配：	N/A。
干预模型：	单组分配
掩蔽：	无（开放标签）
主要意图：	治疗
官方标题：	体细胞疾病患者失眠（CBTI）的认知行为疗法（CBTI）
实际学习开始日期：	2018年1月1日
估计初级完成日期：	2021年12月31日
估计 学习完成日期：	2022年7月31日

研究信息的布局表

武器和干预措施

治疗医院

- 

梅奥诊所
美国最佳医院荣誉榜第1名
- 

克利夫兰诊所
美国最佳医院荣誉榜第2名
- 

约翰霍普金斯医院
美国最佳医院荣誉榜第3名
- 

麻省总医院
美国最佳医院荣誉榜第4名
- 

密歇根大学医院
美国最佳医院荣誉榜第5名
- 

倉敷中央医院
日本综合排名第1名
- 

順天堂医院
日本综合排名第2名
- 

藤田医科大学医院
(原藤田保健大学医院)
日本综合排名第3名
- 

北里大学医院
日本综合排名第4名
- 

東京医科大学医院
日本综合排名第5名

新药特效药

阿替索单抗

手臂	干预/治疗
实验：失眠的认知行为疗法（CBTI）	行为：失眠的认知行为疗法（CBTI） 患者将接受7次课程的认知行为疗法治疗失眠。
结果措施	
主要结果指标：	
1. 失眠严重程度的变化[时间范围：基线（在第一届会议之前），第6次会议（最后一个普通会议，基线后5-7周），第7届会议（上次普通会议后2个月）和完成后6个月课程。这是给予的	
研究中包括的所有患者将被要求完成失眠严重程度指数（ISI；最小值= 0；最大值= 4。较高的分数= 4的结果较差），以评估失眠症症状的任何变化。	
2. 失眠症症状的改变[时间范围：基线（在第一届会议之前），第6节（最后一个普通会议，基线后5-7周），第7次会议（上次普通会议后2个月）和完成后6个月课程。这是给予的	
研究中包括的所有患者将被要求完成卑尔根失眠量表（最小值= 0;最大值= 7。分数较高的结果较差），以评估失眠症症状的任何变化	
次要结果度量：	
1. 睡眠效率的变化[时间范围：基线时的睡眠效率计算（在第一届会议之前），第6节（最后一次普通会议，基线后5-7周），第7次会议（上次普通会议后2个月）和6个月完成课程后，将进行比较。这是给予的	
研究中包括的所有患者将在整个课程的整个过程中保持睡眠日记。睡眠效率将根据睡眠日记计算。	
2. 改变功能失调的信念和对睡眠的态度[时间范围：基线时（在第一届会议之前），第6次会议（最后一次普通会议，基线后5-7周），第7届会议（上一次普通会议后2个月）和6个月完成课程后。这是给予的	
该研究中包括的所有患者都将被要求完成对睡眠量表的功能失调的信念和态度（DBAS-16;最低= 0;最大值= 10。较高的值较高的结果较差），以评估功能失调的信念和对睡眠的态度的任何变化。	
3. 对缺乏睡眠的疲倦和负面后果的白天进行的改变[时间范围：基线（在第一届会议之前），第6节（最后一次普通会议，基线之后5-7周），第7次（最后一个普通的2个月）会议）和完成课程后6个月。这是给予的	
研究中包括的所有患者将被要求完成白天失眠症状反应量表（DISRS;最小= 1;最大值4.最大值4.值较高的预后较差），以评估有关失眠症症状的任何反省变化。	
4. 更改符合睡眠卫生措施[时间范围：基线（在第一届会议之前），在第6节（上次普通会议，基线后5-7周），第7次会议（上次普通会议后2个月）和后6个月后完成课程。这是给予的	
研究中包括的所有患者将被要求完成睡眠卫生指数（SHI-13；最小值= 1；最大值=5。更高的值较高的值表示较差的结果），以评估符合睡眠卫生措施的任何变化。	
5. 抑郁症状的变化[时间范围：基线（在第一届会议之前），第6节（最后一次普通会议，基线后5-7周），第7届会议（上次普通会议后2个月）和完成后6个月课程。]]	
研究中包括的所有患者将被要求完成患者健康调查表9（PHQ-9；最小值= 0；最大值= 3。较高的值较高的值表示较差的结果），以评估抑郁症状的任何变化。	
6. 焦虑症状的变化[时间范围：基线（在第一届会议之前），第6节（最后一次普通会议，基线后5-7周），第7届会议（上次普通会议后2个月）和完成后6个月课程]	
该研究中包括的所有患者将被要求完成广泛的焦虑症量表-7（GAD-7；最小值= 0;最大值= 3。较高的值较高的值表示较差的结果），以评估焦虑症状的任何变化。	
7. 变化体细胞症状[时间范围：基线（在第一届会议之前），第6节（最后一次普通会议，基线后5-7周），第7届会议（上次普通会议后2个月）和完成课程后的6个月这是给予的	
研究中包括的所有患者将被要求完成躯体症状量表-9（SSS-8；最小值= 0;最大值= 4。更高的值较高的值平均较差），以评估躯体症状负担的任何变化	
资格标准	

阿霉素
Mutamycin
阿霉素
环磷酸胺（口服和注射）
蒽奥帕
厄达菲替尼
依维莫司
阿那曲唑
曲妥珠单抗

前沿医讯

为什么Dana-Farber护士喜欢他们所...
表观遗传学：它如何运作以及对癌...
小儿肝肿瘤的研究和治疗方面有哪...
关于乳腺癌年轻女性的十件事
FDA批准了针对淋巴瘤患者的第二...
使用大胆策略增强CAR T细胞疗法
手机会导致癌症吗？
有几个月的生命，肾脏癌患者无可...
大肠癌治疗和研究中有什么新内容？
关于早期癌症检测的五件事

符合研究资格的年龄：	18岁以上（成人，老年人）
有资格学习的男女：	全部
接受健康的志愿者：	不

有资格信息的布局表

标准

纳入标准：

长达18年的男性和女性患有失眠和合并症的体细胞疾病。

排除标准：

无法提供知情同意

无法阅读和/或理解挪威语

无法完成调查

严重的精神障碍，例如精神分裂症和躁郁症

智力或痴呆症

已知的药物滥用

睡眠障碍，例如麻醉症或高血压

联系人和位置

联系人

联系人：医学博士KåreOsnes博士	0047 22029800	kare.osnes@diakonsyk.no	

位置联系人的布局表

位置

挪威	
挪威奥斯陆Diakonhjemmet医院精神病学系	招募
奥斯陆，挪威	
联系人：医学博士KåreOsnes博士0047 22029800 kare.osnes@diakonsyk.no	

位置表的布局表

赞助商和合作者

Diakonhjemmet医院

调查人员

首席研究员：	医学博士KåreOsnes博士	挪威奥斯陆Diakonhjemmet医院精神病学系	

调查员信息的布局表

追踪信息	
首先提交的日期 ^{IC} MJE	2020年7月6日
第一个发布日期 ^{IC} MJE	2020年10月22日
最后更新发布日期	2021年2月4日

实际学习 开始日期 ICMJE	2018年1月1日
估计初级 完成日期	2021年12月31日（主要结果度量的最终数据收集日期）
当前的主 要结果度 量 ICMJE （提交： 2020年1 0月16 日）	失眠严重程度的变化[时间范围：基线（在第一届会议之前），第6次会议（最后一个普通会议，基线后5-7周），第7届会议（上次普通会议后2个月）和完成后6个月课程。这是给予的 研究中包括的所有患者将被要求完成失眠严重程度指数（ISI；最小值= 0；最大值= 4。较高的分数= 4的结果较差），以评估失眠症症状的任何变化。 失眠症症状的改变[时间范围：基线（在第一届会议之前），第6节（最后一个普通会议，基线后5-7周），第7次会议（上次普通会议后2个月）和完成后6个月课程。这是给予的 研究中包括的所有患者将被要求完成卑尔根失眠量表（最小值= 0;最大值= 7。分数较高的结果较差），以评估失眠症症状的任何变化
原始主要 结果措施 ICMJE	与电流相同
改变历史	
当前的次 要结果度 量 ICMJE （提交： 2020年1 0月16 日）	睡眠效率的变化[时间范围：基线时的睡眠效率计算（在第一届会议之前），第6节（最后一次普通会议，基线后5-7周），第7次会议（上次普通会议后2个月）和6个月完成课程后，将进行比较。这是给予的 研究中包括的所有患者将在整个课程的整个过程中保持睡眠日记。睡眠效率将根据睡眠日记计算。 改变功能失调的信念和对睡眠的态度[时间范围：基线时（在第一届会议之前），第6次会议（最后一次普通会议，基线后5-7周），第7届会议（上一次普通会议后2个月）和6个月完成课程后。这是给予的 该研究中包括的所有患者都将被要求完成对睡眠量表的功能失调的信念和态度（DBAS-16;最低= 0;最大值= 10。较高的值较高的结果较差），以评估功能失调的信念和对睡眠的态度的任何变化。 对缺乏睡眠的疲倦和负面后果的白天进行的改变[时间范围：基线（在第一届会议之前），第6节（最后一次普通会议，基线之后5-7周），第7次（最后一个普通的2个月）会议）和完成课程后6个月。这是给予的 研究中包括的所有患者将被要求完成白天失眠症状反应量表（DISRS;最小= 1;最大值4.最大值4.值较高的预后较差），以评估有关失眠症症状的任何反省变化。 更改符合睡眠卫生措施[时间范围：基线（在第一届会议之前），在第6节（上次普通会议，基线后5-7周），第7次会议（上次普通会议后2个月）和后6个月后完成课程。这是给予的 研究中包括的所有患者将被要求完成睡眠卫生指数（SHI-13；最小值= 1；最大值=5。更高的值较高的值表示较差的结果），以评估符合睡眠卫生措施的任何变化。 抑郁症状的变化[时间范围：基线（在第一届会议之前），第6节（最后一次普通会议，基线后5-7周），第7届会议（上次普通会议后2个月）和完成后6个月课程。]] 研究中包括的所有患者将被要求完成患者健康调查表9（PHQ-9；最小值= 0；最大值= 3。较高的值较高的值表示较差的结果），以评估抑郁症状的任何变化。 焦虑症状的变化[时间范围：基线（在第一届会议之前），第6节（最后一次普通会议，基线后5-7周），第7届会议（上次普通会议后2个月）和完成后6个月课程] 该研究中包括的所有患者将被要求完成广泛的焦虑症量表-7（GAD-7；最小值= 0;最大值= 3。较高的值较高的值表示较差的结果），以评估焦虑症状的任何变化。 变化体细胞症状[时间范围：基线（在第一届会议之前），第6节（最后一次普通会议，基线后5-7周），第7届会议（上次普通会议后2个月）和完成课程后的6个月这是给予的 研究中包括的所有患者将被要求完成躯体症状量表-9（SSS-8；最小值= 0;最大值= 4。更高的值较高的值平均较差），以评估躯体症状负担的任何变化
原始次要 结果措施 ICMJE	与电流相同

当前其他预先指定的结果指标	不提供
其他其他预先指定的结果指标	不提供
描述性信息	
简短的标题ICMJE	体细胞疾病患者失眠（CBTI）的认知行为疗法（CBTI）
官方标题ICMJE	体细胞疾病患者失眠（CBTI）的认知行为疗法（CBTI）
简要摘要	失眠症常见于合并症，例如风湿病，癌症，心脏和肺部疾病或胃肠道疾病。疼痛，呼吸困难的和其他症状会使睡眠问题恶化并引起失眠。反过来，失眠可能会加剧疼痛，疲劳并降低体细胞疾病患者的生活质量。该项目旨在评估Diakonhjemmet医院为失眠和体细胞疾病患者提供的课程。该课程基于认知行为疗法，这是一种记录的失眠治疗方法。
详细说明	不提供
研究类型ICMJE	介入
研究阶段ICMJE	不适用
研究设计ICMJE	分配：N/A 干预模型：单个小组分配 蒙版：无（打开标签） 主要目的：治疗
条件ICMJE	失眠 失眠慢性 睡眠启动和维持障碍 睡眠障碍 睡眠障碍 慢性病 由于疾病而失眠 失眠，心理生理学
干预ICMJE	行为：失眠的认知行为疗法（CBTI） 患者将接受7次课程的认知行为疗法治疗失眠。
研究臂ICMJE	实验：失眠的认知行为疗法（CBTI） 干预：行为：失眠的认知行为疗法（CBTI）
出版物 *	不提供
*包括数据提供商提供的出版物以及MEDLINE中临床标识符（NCT编号）确定的出版物。	
招聘信息	
招聘状态ICMJE	招募

估计注册 ICMJE (提交: 2020年10月16日)	40
原始估计注册 ICMJE	与电流相同
估计的研究完成日期 ICMJE	2022年7月31日
估计初级完成日期	2021年12月31日 (主要结果度量的最终数据收集日期)
资格标准 ICMJE	纳入标准: 长达18年的男性和女性患有失眠和合并症的体细胞疾病。 排除标准: 无法提供知情同意 无法阅读和/或理解挪威语 无法完成调查 严重的精神障碍, 例如精神分裂症和躁郁症 智力或痴呆症 已知的药物滥用 睡眠障碍, 例如麻醉症或高血压
性别/性别 ICMJE	有资格学习的男女: 全部
年龄 ICMJE	18岁以上 (成人, 老年人)
接受健康的志愿者 ICMJE	不
联系 ICMJE	联系人: 医学博士KåreOsnes博士 0047 22029800 kare.osnes@diakonsyk.no
列出的位置国家 ICMJE	挪威
删除了位置国家	
管理信息	
NCT编号 ICMJE	NCT04598672
其他研究ID编号 ICMJE	2017/516 (PVO OUS)
有数据监测委员会	不

美国FDA调节的产品	研究美国FDA调节的药物：不 研究美国FDA调节的设备产品：不
IPD共享语句 ^{ICMJE}	计划共享IPD：不
责任方	diakonhjemmet医院KåreOsnes
研究赞助商 ^{ICMJE}	Diakonhjemmet医院
合作者 ^{ICMJE}	不提供
研究人员 ^{ICMJE}	首席研究员：医学博士KåreOsnes博士 挪威奥斯陆Diakonhjemmet医院精神病学系
PRS帐户	Diakonhjemmet医院
验证日期	2021年2月
国际医学杂志编辑委员会和世界卫生组织ICTRP要求的 ^{ICMJE} 数据要素	

研究描述

简要摘要：

失眠症常见于合并症，例如风湿病' target='_blank'>风湿病，癌症，心脏和肺部疾病或胃肠道疾病。疼痛，呼吸困难的疾病的其他症状会使睡眠问题恶化并引起失眠。反过来，失眠可能会加剧疼痛，疲劳并降低体细胞疾病患者的生活质量。该项目旨在评估Diakonhjemmet医院为失眠和体细胞疾病患者提供的课程。该课程基于认知行为疗法，这是一种记录的失眠治疗方法。

病情或疾病	干预/治疗	阶段
失眠失眠症慢性睡眠开始和维持障碍睡眠障碍睡眠障碍慢性疾病失眠，由于疾病失眠，心理生理学	行为：失眠的认知行为疗法（CBTI）	不适用

学习规划

研究类型：	介入（临床试验）
估计入学人数：	40名参与者
分配：	N/A。
干预模型：	单组分配
掩蔽：	无（开放标签）
主要意图：	治疗
官方标题：	体细胞疾病患者失眠（CBTI）的认知行为疗法（CBTI）
实际学习开始日期：	2018年1月1日
估计初级完成日期：	2021年12月31日
估计 学习完成日期：	2022年7月31日

研究信息的布局表

武器和干预措施

手臂	干预/治疗
实验：失眠的认知行为疗法（CBTI）	行为：失眠的认知行为疗法（CBTI） 患者将接受7次课程的认知行为疗法治疗失眠。

结果措施

主要结果指标：

- 1. 失眠严重程度变化[时间范围：基线（在第一届会议之前），第6次会议（最后一个普通会议，基线后5-7周），第7届会议（上次普通会议后2个月）和完成后6个月课程。这是给予的研究中包括的所有患者将被要求完成失眠严重程度指数（ISI；最小值= 0；最大值= 4。较高的分数= 4的结果较差），以评估失眠症状的任何变化。
- 2. 失眠症状的改变[时间范围：基线（在第一届会议之前），第6节（最后一个普通会议，基线后5-7周），第7次会议（上次普通会议后2个月）和完成后6个月课程。这是给予的研究中包括的所有患者将被要求完成卑尔根失眠量表（最小值= 0;最大值= 7。分数较高的结果较差），以评估失眠症状的任何变化

次要结果度量：

- 1. 睡眠效率的变化[时间范围：基线时的睡眠效率计算（在第一届会议之前），第6节（最后一次普通会议，基线后5-7周），第7次会议（上次普通会议后2个月）和6个月完成课程后，将进行比较。这是给予的研究中包括的所有患者将在整个课程的整个过程中保持睡眠日记。睡眠效率将根据睡眠日记计算。
- 2. 改变功能失调的信念和对睡眠的态度[时间范围：基线时（在第一届会议之前），第6次会议（最后一次普通会议，基线后5-7周），第7届会议（上一次普通会议后2个月）和6个月完成课程后。这是给予的该研究中包括的所有患者都将被要求完成对睡眠量表的功能失调的信念和态度（DBAS-16;最低= 0;最大值= 10。较高的值较高的结果较差），以评估功能失调的信念和对睡眠的态度的任何变化。
- 3. 对缺乏睡眠的疲倦和负面后果的白天进行的改变[时间范围：基线（在第一届会议之前），第6节（最后一次普通会议，基线之后5-7周），第7次（最后一个普通的2个月）会议）和完成课程后6个月。这是给予的研究中包括的所有患者将被要求完成白天失眠症状反应量表（DISRS;最小= 1;最大值4.最大值4.值较高的预后较差），以评估有关失眠症状的任何反省变化。
- 4. 更改符合睡眠卫生措施[时间范围：基线（在第一届会议之前），在第6节（上次普通会议，基线后5-7周），第7次会议（上次普通会议后2个月）和后6个月后完成课程。这是给予的研究中包括的所有患者将被要求完成睡眠卫生指数（SHI-13；最小值= 1；最大值=5。更高的值较高的值表示较差的结果），以评估符合睡眠卫生措施的任何变化。
- 5. 抑郁症状的变化[时间范围：基线（在第一届会议之前），第6节（最后一次普通会议，基线后5-7周），第7届会议（上次普通会议后2个月）和完成后6个月课程。]]
研究中包括的所有患者将被要求完成患者健康调查表9（PHQ-9；最小值= 0；最大值= 3。较高的值较高的值表示较差的结果），以评估抑郁症状的任何变化。
- 6. 焦虑症' target='_blank'>焦虑症状的变化[时间范围：基线（在第一届会议之前），第6节（最后一次普通会议，基线后5-7周），第7届会议（上次普通会议后2个月）和完成后6个月课程]
该研究中包括的所有患者将被要求完成广泛的焦虑症' target='_blank'>焦虑症量表-7（GAD-7；最小值= 0;最大值= 3。较高的值较高的值表示较差的结果），以评估焦虑症' target='_blank'>焦虑症状的任何变化。
- 7. 变化体细胞症状[时间范围：基线（在第一届会议之前），第6节（最后一次普通会议，基线后5-7周），第7届会议（上次普通会议后2个月）和完成课程后的6个月这是给予的研究中包括的所有患者将被要求完成躯体症状量表-9（SSS-8；最小值= 0;最大值= 4。更高的值较高的值平均较差），以评估躯体症状负担的任何变化

资格标准

符合研究资格的年龄：	18岁以上（成人，老年人）
有资格学习的男女：	全部
接受健康的志愿者：	不

有资格信息的布局表

标准

纳入标准：

长达18年的男性和女性患有失眠和合并症的体细胞疾病。

排除标准：

无法提供知情同意

无法阅读和/或理解挪威语

无法完成调查

严重的精神障碍，例如精神分裂症和躁郁症

智力或痴呆症

已知的药物滥用

睡眠障碍，例如麻醉症或高血压

联系人和位置

联系人

联系人：医学博士KåreOsnes博士	0047 22029800	kare.osnes@diakonsyk.no	

位置联系人的布局表

位置

挪威	
挪威奥斯陆Diakonhjemmet医院精神病学系	招募
奥斯陆，挪威	
联系人：医学博士KåreOsnes博士0047 22029800 kare.osnes@diakonsyk.no	

位置表的布局表

赞助商和合作者

Diakonhjemmet医院

调查人员

首席研究员：	医学博士KåreOsnes博士	挪威奥斯陆Diakonhjemmet医院精神病学系	

调查员信息的布局表

追踪信息	
首先提交的日期 ^{IC} MJE	2020年7月6日
第一个发布日期 ^{IC} MJE	2020年10月22日
最后更新发布日期	2021年2月4日
实际学习开始日期 ^{ICMJE}	2018年1月1日
估计初级完成日期	2021年12月31日（主要结果度量的最终数据收集日期）
当前的主要结果度量 ^{ICMJE} (提交：2020年10月16日)	失眠严重程度的变化[时间范围：基线（在第一届会议之前），第6次会议（最后一个普通会议，基线后5-7周），第7届会议（上次普通会议后2个月）和完成后6个月课程。这是给予的研究中包括的所有患者将被要求完成失眠严重程度指数（ISI；最小值= 0；最大值= 4。较高的分数= 4的结果较差），以评估失眠症症状的任何变化。 失眠症症状的改变[时间范围：基线（在第一届会议之前），第6节（最后一个普通会议，基线后5-7周），第7次会议（上次普通会议后2个月）和完成后6个月课程。这是给予的研究中包括的所有患者将被要求完成卑尔根失眠量表（最小值= 0;最大值= 7。分数较高的结果较差），以评估失眠症症状的任何变化

原始主要结果措施 ICMJE	与电流相同
改变历史	
当前的次要结果度量 ICMJE （提交：2020年10月16日）	睡眠效率的变化[时间范围：基线时的睡眠效率计算（在第一届会议之前），第6节（最后一次普通会议，基线后5-7周），第7次会议（上次普通会议后2个月）和6个月完成课程后，将进行比较。这是给予的 研究中包括的所有患者将在整个课程的整个过程中保持睡眠日记。睡眠效率将根据睡眠日记计算。 改变功能失调的信念和对睡眠的态度[时间范围：基线时（在第一届会议之前），第6次会议（最后一次普通会议，基线后5-7周），第7届会议（上一次普通会议后2个月）和6个月完成课程后。这是给予的 该研究中包括的所有患者都将被要求完成对睡眠量表的功能失调的信念和态度（DBAS-16;最低= 0; 最大值= 10。较高的值较高的结果较差），以评估功能失调的信念和对睡眠的态度的任何变化。 对缺乏睡眠的疲倦和负面后果的白天进行的改变[时间范围：基线（在第一届会议之前），第6节（最后一次普通会议，基线之后5-7周），第7次（最后一个普通的2个月）会议）和完成课程后6个月。这是给予的 研究中包括的所有患者将被要求完成白天失眠症状反应量表（DISRS;最小= 1;最大值4.最大值4.值较高的预后较差），以评估有关失眠症状的任何反省变化。 更改符合睡眠卫生措施[时间范围：基线（在第一届会议之前），在第6节（上次普通会议，基线后5-7周），第7次会议（上次普通会议后2个月）和后6个月后完成课程。这是给予的 研究中包括的所有患者将被要求完成睡眠卫生指数（SHI-13；最小值= 1；最大值=5。更高的值较高的值表示较差的结果），以评估符合睡眠卫生措施的任何变化。 抑郁症状的变化[时间范围：基线（在第一届会议之前），第6节（最后一次普通会议，基线后5-7周），第7届会议（上次普通会议后2个月）和完成后6个月课程。]] 研究中包括的所有患者将被要求完成患者健康调查表9（PHQ-9；最小值= 0；最大值= 3。较高的值较高的值表示较差的结果），以评估抑郁症状的任何变化。 焦虑症' target='_blank'>焦虑症状的变化[时间范围：基线（在第一届会议之前），第6节（最后一次普通会议，基线后5-7周），第7届会议（上次普通会议后2个月）和完成后6个月课程] 该研究中包括的所有患者将被要求完成广泛的焦虑症' target='_blank'>焦虑症量表-7（GAD-7；最小值= 0;最大值= 3。较高的值较高的值表示较差的结果），以评估焦虑症' target='_blank'>焦虑症状的任何变化。 变化体细胞症状[时间范围：基线（在第一届会议之前），第6节（最后一次普通会议，基线后5-7周），第7届会议（上次普通会议后2个月）和完成课程后的6个月这是给予的 研究中包括的所有患者将被要求完成躯体症状量表-9（SSS-8；最小值= 0;最大值= 4。更高的值较高的值平均较差），以评估躯体症状负担的任何变化
原始次要结果措施 ICMJE	与电流相同
当前其他预先指定的结果指标	不提供
其他其他预先指定的结果指标	不提供
描述性信息	
简短的标题 ICMJE	体细胞疾病患者失眠（CBTI）的认知行为疗法（CBTI）
官方标题 ICMJE	体细胞疾病患者失眠（CBTI）的认知行为疗法（CBTI）

简要摘要	失眠症常见于合并症，例如 风湿病 风湿病 ，癌症，心脏和肺部疾病或胃肠道疾病。疼痛，呼吸困难和疾病的其他症状会使睡眠问题恶化并引起失眠。反过来，失眠可能会加剧疼痛，疲劳并降低体细胞疾病患者的生活质量。该项目旨在评估Diakonhjemmet医院为失眠和体细胞疾病患者提供的课程。该课程基于认知行为疗法，这是一种记录的失眠治疗方法。
详细说明	不提供
研究类型 ICMJE	介入
研究阶段 ICMJE	不适用
研究设计 ICMJE	分配：N/A 干预模型：单个小组分配 蒙版：无（打开标签） 主要目的：治疗
条件 ICMJE	失眠 失眠慢性 睡眠启动和维持障碍 睡眠障碍 睡眠障碍 慢性病 由于疾病而失眠 失眠，心理生理学
干预 ICMJE	行为：失眠的认知行为疗法（CBTI） 患者将接受7次课程的认知行为疗法治疗失眠。
研究臂 ICMJE	实验：失眠的认知行为疗法（CBTI） 干预：行为：失眠的认知行为疗法（CBTI）
出版物 *	不提供
*包括数据提供商提供的出版物以及MEDLINE中临床标识符（NCT编号）确定的出版物。	
招聘信息	
招聘状态 ICMJE	招募
估计注册 ICMJE (提交： 2020年 10月16 日)	40
原始估计 注册 ICMJE	<i>与电流相同</i>
估计的研究 完成日期 ICMJE	2022年7月31日
估计初级 完成日期	2021年12月31日（主要结果度量的最终数据收集日期）

资格标准 ICMJE	纳入标准： 长达18年的男性和女性患有失眠和合并症的体细胞疾病。 排除标准： 无法提供知情同意 无法阅读和/或理解挪威语 无法完成调查 严重的精神障碍，例如精神分裂症和躁郁症 智力或痴呆症 已知的药物滥用 睡眠障碍，例如麻醉症或高血压
性别/性别 ICMJE	有资格学习的男女： 全部
年龄 ICMJE	18岁以上（成人，老年人）
接受健康的志愿者 ICMJE	不
联系 ICMJE	联系人：医学博士KåreOsnes博士 0047 22029800 kare.osnes@diakonsyk.no
列出的位置国家 ICMJE	挪威
删除了位置国家	
管理信息	
NCT编号 ICMJE	NCT04598672
其他研究ID编号 ICMJE	2017/516 (PVO OUS)
有数据监测委员会	不
美国FDA调节的产品	研究美国FDA调节的药物： 不 研究美国FDA调节的设备产品： 不
IPD共享 语句 ICMJE	计划共享IPD： 不
责任方	diakonhjemmet医院KåreOsnes
研究赞助商 ICMJE	Diakonhjemmet医院
合作者 ICMJE	不提供
研究人员 ICMJE	首席研究员： 医学博士KåreOsnes博士 挪威奥斯陆Diakonhjemmet医院精神病学系
PRS帐户	Diakonhjemmet医院
验证日期	2021年2月

相关推荐

美国治疗医生

本站数据来源：

usnews.com 日本厚生劳动省 日本医疗护理信息局

相关查询：

就医指南 药品问答

最新医生信息：

渡邊剛 宮崎総一郎 溝上裕士 百村伸一 山内広平 吉井文均 村上和成 中山秀章 広川雅之 村田朗

最新医院信息：

大幸砂田橋クリニック 天理よろづ相談所医院白川分院 姫路赤十字医院 遠山医院 三重中央医療中心 聖バルナバ医院 大西脳神経外科医院 伊月医院 国吉医院 ah早综合医院

继发性红细胞增多症	嗜酸粒细胞白血病	妊娠合并特发性血小...	儿童骨髓增生异常综...	非典型溶血性尿毒症...	血卟啉病
红白血病	全血细胞减少	特发性血小板减少性...	血管性血友病	遗传性血小板减少症	婴幼儿巨幼细胞性贫血
肺癌脑转移	肺腺癌	副肿瘤性脊髓病	肛管癌	睾丸间质细胞瘤	宫颈浸润癌
骨膜性软骨肉瘤	骨旁骨肉瘤	骨纤维肉瘤	海绵窦脑膜瘤	黄色瘤	IV期非小细胞肺癌
基底细胞腺瘤	结肠类癌	结肠平滑肌瘤	结缔组织增生性毛发...	精囊恶性肿瘤	脊柱原发性肿瘤
空肠恶性肿瘤	老年人肺癌	颅骨骨瘤	颅骨转移瘤	毛发上皮瘤	脑结核瘤
脑室内脑膜瘤	黏液腺癌	黏液性腺癌	尿道旁腺癌	胚胎癌	皮肤淋巴瘤细胞瘤
皮肤脑膜瘤	妊娠合并子宫肌瘤	乳房外湿疹样癌	上颌窦癌	声门上型喉癌	神经鞘黏液瘤